



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سعاد ثابت سليمان محمد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : دار السلام
رقم البطاقة : 28507172603087 رقم التليفون : 01144555073
العنوان : ممممممممممممممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 17-07-1985 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سعاد ثابت سليمان محمد National ID: 28507172603087	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
 وزارة الداخلية
 مصلحة الأحوال المدنية

سعاد
 ثابت سليمان محمد
 ٣٣ امتداد اسماعيل النيلي
 دار السلام - القاهرة

٢٨٥٠٧١٧٢٦-٣٠٨٧

١٧٤١٩١٢٦٢



٢٠٢١/٢٨
 ٢٨٥٠٧١٧٢٦-٣٠٨٧
 ربة منزل
 أمشي
 محمد كمال محمد إبراهيم
 ٣٣٨٧/٠٨/٠٨
 البطاقة سارية حتى







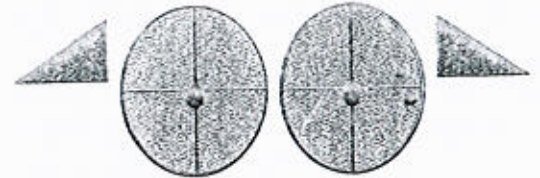

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستشارة
طبية
مختصة

13-9-2021

MDT FORM

Name	د. محمد عبد الله
Age	36
MRN	
ID	01144555073
Co morbidity	



Clinical Data

Bx:	IDC grade II	SM:	Lt 400 Multifocal malignant mass at 3 o'clock adjacent 2 similar lesions.
IHC:		Mets Workup:	force
ER:	8/8		
PR:	6/8		
Her2:	0%		
KITV:	100%		
PT2 N0 M0 (IHC)			
COMMENT: post Lt mastectomy + SLN free margins, nipple, LN → 3/5 (micro-metas) for post-operative MDT			

MDT OUTCOME & PLAN

for adjuvant chemo. Taxotere + Endoxan
X4 cycles then PORT

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. محمد عبد الله	د. محمد عبد الله	د. محمد عبد الله	



National Women's Health Initiative
Pathology Lab
معمل باثولوجي المبادرة القومية لصحة المرأة



Pathology Report

Name: سعاد ثابت سليمان محمد

Age: 36 years.

Clinical data: Lt breast cancer

Specimen type: simple mastectomy & SLN

Date (Received): 4/8/2021.

Date (reported): 7/8/2021

Lab. Number: 1671/ 21

Hospital Number:

Gross Examination:

- Procedure: simple mastectomy
- Localization: Lt
- Tumor extent: one mass 2.3x2cm
 - Skin involvement: no
- Distance from margins: 0.5 cm (deep margin)
- Lymph nodes number and size: 5 nodules up to 1.5x1cm

Microscopic examination:

- Histological type: IDC GII
- Angioinvasion: POSITIVE
- Lymph node involvement: 1/5 (micrometastasis)
- Resection Margins: free
- Additional pathologic findings: extensive perineural invasion

Diagnosis:

Lt breast cancer, simple mastectomy:

- Invasive duct carcinoma GII
- Free margins & nipple.
- Lymph nodes 1/5 (micrometastasis)
- Stage ypT2 ypN1mi

Prof. Amal Hareedy

Dr. Rana Fathy



National Women's Health Initiative
Pathology Lab
معمل باثولوجي المبادرة القومية لصحة المرأة



Pathology Report

Name: سعاد ثابت سليمان محمد

Age: 35 3years.

Clinical data: Left Breast Lesion.

Specimen type: Tru cut biopsy.

Date (Received): 13 /6/202.

Date(reported): 28/6/2021(IPT)

Lab. Number: 1234/ 21(final)

Hospital Number: صحة المرأة

Gross Examination:

- Procedure: Tru cut biopsy
- Localization: Left breast mass
- Tumor extent
 - Number: N/A
 - Size: N/A
 - Skin involvement: N/A
- Distance from margins: N/A
- Lymph nodes number and size: N/A
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II

- Angioinvasion:
- Ductal carcinoma in situ:
- Tumor extent
 - Number:
 - Size:
 - Skin involvement:
- Lymph node involvement:
- Resection Margins:
 - Free /DCIS/ invasive carcinoma
- Additional pathologic findings:

Diagnosis:

Left breast mass; Tru-cut biopsy::

- Histological type: invasive duct carcinoma
- Tumor grade: 2
- **ER: Strong 90% nuclear reaction (Allred score 8/8)**
- **PR: Strong 90%% nuclear reaction (Allred score 6/8)**
- **Her2: No membrane reaction (score 0)**
- **KI67: 10% nuclear reaction.**

Prof. Dr. Aml Hareedy

Dr/ Walaa Ghonaim.



Women's Health Outreach Program

Name: Soaad Thabet Soliman

Date: 13/06/2021

Full field Bilateral Digital Mammography & ultrasonography

Clinical summary:

Left palpable lump

Detailed Findings

Technique

Craniocaudal & mediolateral oblique views

High resolution ultrasound

Left breast

- ACR C density. Heterogeneously dense breast
- UOQ irregular shaped dense spiculated mass with related architectural distortion
- Ultrasound demonstrated 3 o'clock irregular shaped hypoechoic mass lesions with spiculated margins, it measures about 2.1x1.73cm (corresponding to the palpable lesion, the index lesion)
- Adjacent two similar lesions seen measures 1.9x0.96 cm and 0.6x0.5cm with about 0.7cm distance in between.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Right breast

- ACR B density. Scattered fibroglandular densities
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Conclusion:

-Left breast: UOQ multifocal probably malignant process (BIRADS4c) (highly suspicious).

-Right breast: Normal study (BIRADS2).

Recommendation

US guided biopsy was taken from the index lesion at the clinical setting.

Contrast based study

Dr.Marwa Ramzy, MSc.
Dr. Lamiaa Adel, MD

Patient Name: Soaad Thabet Soliman

Date: 9/2/2024

Referring physician: Prof.

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information: *skeletal surveying to detect multiple lesions.*

Technique: Anterior and posterior whole-body scan performed 2 hours after I.V. administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP:

Report:

- No scientigraphic evidence of bony metastases .
- Heterogenous abnormal radiotracer uptake is seen at the spine , more determined at mid , dorsal , lower lumbar vertebrae ,, likely of spondylodegenerative changes
 - Osteoarthritic changes are seen at both knees, both shoulders ,
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

No active osseous metastatic lesions could be seen all over the surveyed skeleton .

Nuclear Medicine Unit

DR . Sherin Mahdy, MD

DR/ Mohamed Emam

Dr. Nagy Salah El-Din El-Soliman
Date: 05/07/2022

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

A case with history of breast cancer.

1. Chest:

- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions
- Mildly enlarged left axillary lymph nodes measures about 1.7x1.4cm
- No mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses.
- No cardiomegaly.
- No pericardial effusion detected.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous CT texture and smooth outline , no pathologically enhancing focal lesions.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, adrenals, aorta and IVC.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Good filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Large fat containing umbilical hernia with defect measures 2.3 cm at diameter.
- No periaxial collections.

OPINION:

- *Mildly enlarged left axillary lymph nodes*
- *No evidence of metastatic disease could be detected.*

Dr. Nagy Salah

Dr. M. Gomaa, M.D.



وزارة الصحة والسكان
منطقة مصر القديمة الطبية
مستشفى دار السلام العام

تقرير طبي

السيد مديبر / مستشفى جوتافا روس

بعد التحية ،،،

بناءً على الطلب المقدم من السيد سمحوا وابتسموا
نفيد سيادكم بأن السيد / معد ثابت سليمان محمد

بطاقة : ٢٠٢٦٠٧١٧٢٦٠٣٠٨٧٢ سجل مدني :

لقد عولج بالمستشفى بالقسم الخارجي .

من : ٨ / ٩ / ٢٠٢٦ إلى : ٨ / ٩ / ٢٠٢٦

أدخل المستشفى بتاريخ : ٨ / ٩ / ٢٠٢٦

للعلاج من حالة : تشمع رئوي حاد

أي مشاكل أخرى بالأنف

وخرج من المستشفى بتاريخ : ٨ / ٩ / ٢٠٢٦

وننصح له بإجازة لمدة :

وتفصلوا بقبول فائق الشكر والاحترام

مدير المستشفى

الطبيب المعالج

٢٠٢٦/٩/٨
٢٠٢٦/٩/٨
٢٠٢٦/٩/٨

أحمد فريد عيسى

